Apoio Matricial na Atenção Primária à Saúde

PONTOS IMPORTANTES

- PONTOS IMPORTANTES
- O Apoio Matricial é uma estratégia fundamental para a integralidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS), integrando equipes de Saúde da Família (eSF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- Sua atuação abrange dimensões técnico-pedagógicas e assistenciais, fortalecendo a capacidade resolutiva das equipes e aprimorando a gestão de casos complexos, especialmente em saúde mental.
- A implementação requer coordenação eficaz, reuniões periódicas e educação permanente dos profissionais, materializando-se em consultas conjuntas e visitas domiciliares.
- Desafios incluem a carência de conhecimento sobre o modelo, dificuldades relacionais, estigma e formação acadêmica deficiente.

Educação Permanente e Capacitação Profissional

A educação permanente e a formação dos profissionais são igualmente cruciais para o êxito do Apoio Matricial. Programas de capacitação auxiliam os profissionais a se familiarizarem com as práticas de matriciamento e a desenvolverem as competências necessárias para implementar eficazmente as estratégias de cuidado, sendo este um aspecto essencial em áreas onde se identificam lacunas de conhecimento acerca do matriciamento6.

Barreiras na Implementação do Apoio Matricial

Não obstante, a implementação do Apoio Matricial defronta-se com desafios significativos. A carência de conhecimento apropriado sobre o Apoio Matricial entre gestores e profissionais de saúde pode comprometer a aplicação das práticas e ferramentas propostas, culminando em uma implementação ineficaz. Isso engloba a ausência de participação ativa dos profissionais e o estigma associado às condições de saúde, o qual pode impactar a adesão ao modelo6. Adicionalmente, dificuldades relacionais e organizacionais são frequentemente observadas, com problemas como a fragmentação do cuidado e a ausência de uma abordagem sistemática, que fragilizam a integração entre os serviços (Trata-se de um estudo qualitativo que objetivou analisar as concepções sobre matriciamento em saúde mental3).

A formação acadêmica deficiente dos profissionais constitui outro desafio identificado. A ausência de uma base sólida em práticas de matriciamento pode restringir a capacidade dos profissionais de aplicar efetivamente as estratégias propostas. A educação permanente é imprescindível para transpor essas barreiras e aprimorar a compreensão e a eficácia das práticas matriciais6. Adicionalmente, um estudo conduzido em Itapevi, SP, evidenciou dificuldades específicas nas ações de saúde na Atenção Básica, tais como a reduzida capacidade de identificar demandas e riscos, a propensão à medicalização e a baixa participação dos usuários. Não obstante essas dificuldades, foram obtidos avanços significativos na percepção dos trabalhadores e na mobilização de recursos internos para o cuidado, servindo como alicerce para a introdução do matriciamento7.

H1 Funcionalidade na Prática

Na prática, o Apoio Matricial materializa-se por meio de consultas conjuntas, visitas domiciliares coordenadas, grupos terapêuticos e outras intervenções que respondem de forma

abrangente às diversas demandas de saúde[1]. Essas práticas não somente ampliam o acesso aos cuidados, mas também aprimoram a continuidade do atendimento, assegurando uma resposta mais efetiva às necessidades específicas dos usuários, em particular daqueles com condições crônicas e complexas.

Um estudo procedeu à análise das práticas e concepções do matriciamento em saúde mental sob as perspectivas de equipes de referência, equipes matriciais e gestores. Foram conduzidas entrevistas com 41 participantes e observações totalizando 110 horas das práticas matriciais. O estudo evidenciou duas concepções primordiais sobre o matriciamento: como uma oportunidade de encontro profícuo entre equipes de saúde e como uma estratégia de formação em serviço. As observações corroboraram a necessidade de criar, sistematizar e fortalecer espaços de diálogo entre equipes de referência, equipes matriciais e gestores, visando consolidar o matriciamento e aprimorar suas práticas8.

H1 Potenciais de Organização Futura

Para o porvir, o Apoio Matricial apresenta potencial para expandir-se por meio da integração intersetorial com serviços sociais, educacionais e comunitários9. Esta integração é crucial para o fortalecimento das redes de cuidado, possibilitando uma abordagem mais holística dos determinantes sociais da saúde. A colaboração com esses setores pode não somente aprimorar o acesso e a qualidade dos serviços, mas também fomentar ações preventivas e educativas que são essenciais para a saúde comunitária.

Adicionalmente, a implementação de tecnologias da informação e comunicação (TICs) pode otimizar a gestão de casos e facilitar o compartilhamento de informações entre as equipes de Saúde da Família (eSF) e os serviços especializados. As TICs detêm o potencial de aprimorar a coordenação dos cuidados, apoiar a educação permanente dos profissionais de saúde e assegurar que informações cruciais estejam acessíveis a todos os envolvidos no cuidado. Essas inovações tecnológicas podem contribuir para uma gestão mais eficiente e integrada dos cuidados, elevando a qualidade dos serviços prestados.

Um exemplo pertinente dessa abordagem é a proposta de intervenção elaborada na Região de Saúde de Cruz das Almas. Esta proposta objetiva aprimorar a articulação entre as Equipes de Saúde da Família (eSF) e os serviços existentes, por meio da criação e implementação de uma matriz de intervenção adaptada às necessidades locais. O propósito é fomentar espaços para a promoção e prevenção em saúde, além de prover um cuidado integrado na Atenção Básica. A proposta contempla a realização de encontros de avaliação e adequação, a fim de assegurar que a implementação seja eficaz e atenda às necessidades da comunidade local10.

Adicionalmente, uma perspectiva de valor sobre as estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na Atenção Primária pode ser apresentada ao se abordar o matriciamento. Um estudo qualitativo, desenvolvido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de um município do Rio Grande do Sul, ressalta a necessidade premente de investimentos e suporte para aprimorar as ações de promoção da saúde e prevenção. O artigo identifica o matriciamento como uma potencialidade para fortalecer a atuação da Atenção Primária, sugerindo que um investimento mais substancial na formação e no suporte das equipes pode gerar um impacto significativo na qualidade e eficácia dos cuidados prestados na Atenção Básica11.

Outrossim, um estudo qualitativo conduzido na Região Sul do Brasil evidenciou que, não obstante os esforços para aprimorar o cuidado, persiste um descompasso entre as intenções dos apoiadores e as expectativas dos profissionais de saúde. Este conflito sinaliza a necessidade de reavaliação das práticas e políticas públicas, a fim de assegurar que o Apoio Matricial possa efetivamente promover a saúde e a cidadania na Atenção Primária à Saúde12.

O Apoio Matricial configura uma evolução significativa na maneira como a APS aborda as complexidades de saúde da população. Ao integrar saberes e práticas, esta estratégia não somente fortalece a capacidade de resposta das equipes de eSF e NASF, mas também fomenta uma abordagem mais humanizada e centrada no usuário. A colaboração interdisciplinar, fundamentada em evidências e centrada no usuário, é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde pública, assegurando cuidados mais integrados e eficazes.

Incorporação da Perspectiva Culturalmente Sensível

Por derradeiro, torna-se imperativo incorporar uma perspectiva culturalmente sensível no planejamento e na prática do Apoio Matricial. Embora os profissionais reconheçam a relevância dos condicionantes socioculturais nos casos clínicos e nas interações com usuários e comunidades, a competência cultural ainda se mostra insuficiente para uma compreensão crítica da diversidade cultural. O estímulo ao debate acerca das dimensões socioculturais e a consideração das particularidades culturais podem representar um avanço significativo no cuidado colaborativo. A integração da cultura no planejamento e na prática não somente aprimora a adesão às intervenções, mas também eleva a eficácia das estratégias de cuidado na Atenção Primária8.

O último parágrafo da seção "Potenciais de Organização Futura" contém uma repetição substancial do conteúdo dentro do parêntese. Sugere-se revisar para evitar redundância e otimizar a clareza e concisão do texto, mantendo a informação essencial.

H1 Conclusão

REFERÊNCIAS

[1]COHEN, Marina Chansky. Impasses e potências: o matriciamento como dispositivo de cuidado. Interface (Botucatu, Online), v. 25, e200462, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.200462>.

[2]Como o apoio matricial pode ser desenvolvido na Atenção Básica em Saúde/Atenção Primária em Saúde? Biblioteca Virtual em Saúde, 2015. Disponível em: <https://aps-repo.bvs.br/aps/como-o-apoio-matricial-pode-ser-desenvolvido-na-atencao-basica-em-saudeatencao-primaria-em-saude/>. Acesso em: 14 ago. 2024.

[3]GUSMÃO, Ricardo. Atuação do enfermeiro em saúde mental na estratégia de saúde da família. Journal of Health and Biological Sciences, v. 10, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v10i1.3721.p1-6.2022>.

4FAGUNDES, Giselle Soares. Matriciamento em Saúde Mental: análise do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico na Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n. 6, pp. 2311-2322, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.20032019>.

5IGLESIAS, Alexandra. Matriciamento em Saúde Mental: práticas e concepções trazidas por equipes de referência, matriciadores e gestores. Ciência & Saúde Coletiva (online), v. 24, n. 4, pp. 1247-1254, 2019. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.05362017>.

6IGLESIAS, Alexandra. Conhecendo o matriciamento em saúde mental pela perspectiva dos matriciadores. Espaç.saúde, v. 22, 2021, pp. 1-12, 24. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1353631>.

7OLIVEIRA, Gustavo Costa de. Ações do apoio matricial na Atenção Primária à Saúde: estudo fenomenológico. Acta Paulista de Enfermagem (online), v. 32, n. 6, pp. 674-682, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900093>.

8SANTANA, Elisangela Ferreira de. Proposta de Matriciamento em Saúde Mental nos municípios da Região de Saúde de Cruz das Almas. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Escola Estadual de Saúde Pública, Salvador, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129712>.

9SANTOS, Angela Maria. O matriciamento em saúde mental como dispositivo para a formação e gestão do cuidado em saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva (online), v. 30, n. 04, e300409, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300409>.

10SANTOS, Elitiele Ortiz dos. Avaliação das estratégias de promoção da saúde e prevenção ao uso de drogas na rede psicossocial. Escola Anna Nery (online), v. 27, e20220110, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2022-0110pt>.

11SOUSA, Paulo Henrique Caetano de. Relato da implantação do matriciamento em um município cearense: dos desafios às conquistas. Rev. baiana saúde pública, v. 45, n. 4, pp. 241-251, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2021.v45.n4.a3422>.

12VASCONCELO, Marilena Silva de. Conhecimento de gestores e profissionais da rede de atenção psicossocial sobre matriciamento em saúde mental. Ciênc. cuid. saúde, v. 18, n. 4, e43922, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v18i4.43922>.

13YAMAGUTI, Claudiney Augusto. Grupos de reflexão em Saúde Mental: possibilidade de interlocução entre a Saúde Mental e a Atenção Básica no município de Itapevi – SP. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), v. 20, n. 1, pp. 132-138, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1009105>.

Links para Atualização:

1. *Ministério da Saúde - Atenção Primária à Saúde: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/atencao-primaria-a-saude*

2. *Ministério da Saúde - Saúde Mental: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/saude-mental*

4. *Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC): https://www.sbmfc.org.br/*